# 木花のむら診療所　初期投資シナリオ比較

2026年8月6日

Scenario A（CT開業時導入）vs Scenario B（CT後回し・内視鏡のみ開業時）

船井総研 関根様ご提案を受けた検討資料

⚠ **注記：**現行の銀行提出資料（約21,835万円）には CT・デジタルX線・エコー・心電図の機器購入費が未計上です。本比較では両シナリオとも機器費を適切に計上した上で比較しています。

## ①　初期投資・融資額の比較

| 区分 | Scenario A<br>CT 開業時導入 | Scenario B<br>CT 後回し（M18頃） | 差額（B−A） |
|---|---|---|---|
| 設備資金（建物）<br>CT室特殊工事の有無で変動 | 約15,000万円<br>CT室特殊工事・放射線遮蔽込み | 約14,000万円<br>CT室スケルトン対応のみ（将来設置可） | **▲1,000万円** |
| 設備資金（土地） | 約3,000万円 | 約3,000万円 | — |
| CT機器（リファービッシュ16列）<br>※開業時 or 後払い | 約2,000万円<br>（開業時一括） | 0円<br>（M18頃 別途追加融資） | **▲2,000万円** |
| デジタルX線・エコー・心電図<br>（リファービッシュ・中古購入） | 約580万円 | 約580万円 | — |
| 経鼻内視鏡・FeNO（中古購入） | 約350万円 | 約350万円 | — |
| 開業準備資金<br>IT・HP・看板・内覧会・採用・備品 | 約685万円 | 約685万円 | — |
| 諸費用・調整<br>開発許可・許認可・保険等 | 約300万円 | 約300万円 | — |
| 運転資金<br>開業初期赤字・保険収入2ヶ月遅れ対応 | 約2,500万円 | 約2,500万円 | — |
| **融資希望合計（開業時）** | **約24,400万円** | **約21,400万円** | **▲3,000万円** |

※ Scenario B のCT導入時（M18頃・患者70人/日到達後）：CT機器2,000万＋工事1,000万＝計3,000万円を別途追加融資（7年返済・約38万/月）

## ②　月次返済・固定費の比較

| 項目 | Scenario A（CT開業時） | Scenario B（CT後回し） | 差額（B−A） |
|---|---|---|---|
| 長期借入返済（20年・1.8%）<br>土地＋建物（＋CT機器AのみA） | 約100万円/月<br>（20,000万×20年） | 約85万円/月<br>（17,000万×20年） | **▲15万円/月** |
| 短期借入返済（10年・1.8%）<br>機器・開業準備・運転資金 | 約40万円/月<br>（4,415万×10年） | 約40万円/月<br>（4,415万×10年） | — |
| **借入返済合計（通常返済時）** | **約140万円/月** | **約125万円/月** | **▲15万円/月** |
| 据え置き期間中（利息のみ） | 約37万円/月 | 約32万円/月 | **▲5万円/月** |
| 人件費・薬品・光熱費等（共通） | 352万円/月 | 352万円/月 | — |
| **月次固定費合計（通常返済時）**<br>院長報酬除く | **約492万円/月** | **約477万円/月** | **▲15万円/月** |
| **月次固定費合計（据え置き中）**<br>院長報酬除く | **約389万円/月** | **約384万円/月** | **▲5万円/月** |

## ③　損益分岐点・資金繰りの比較

| 指標 | Scenario A（CT開業時） | Scenario B（CT後回し） | 差額（B−A） |
|---|---|---|---|
| 損益分岐点（据え置き期間中）<br>院長報酬M1〜6：100万含む | 36人/日 | 36人/日 | ほぼ同等 |
| 損益分岐点（通常返済後）<br>院長報酬M13〜：220万含む | 53人/日 | 52人/日 | **▲1人/日** |
| M4 手元残高最低点<br>（運転資金2,500万スタート） | 約1,320万円 | 約1,368万円 | **+48万円** |
| M18〜 月次余剰（70人/日）<br>院長報酬220万含む・CT収益除く | +218万円/月 | +233万円/月 | **+15万円/月** |
| CT導入後の収益上乗せ<br>CT検査50〜100件/月想定 | 開業当初から<br>+40〜150万円/月 | M18以降から<br>+40〜150万円（ただし追加返済▲38万） | — |
| 銀行審査への影響 | 融資額2.44億で審査<br>（前回面談で難色あり） | 融資額2.14億に圧縮<br>（自宅・個人資産8,000万で担保余力大） | **審査通過率↑** |

## ④　戦略的メリット・デメリット比較

| 観点 | Scenario A（CT開業時） | Scenario B（CT後回し） |
|---|---|---|
| **差別化** | 開業初日から「診療圏唯一のCT完備クリニック」を前面に打ち出せる。脳卒中・骨折・腹部疾患の救急対応も即時可能 | 開業〜M18は「内視鏡・外科・DX特化クリニック」として差別化。CT目的の患者は大病院へ紹介 |
| **収益性** | CT収益（1件8,000〜15,000円）が開業初日から発生。月50件で+40〜75万円 | M18まではCT収益なし。ただし月次余剰は+15万円多く、資金繰りに余裕 |
| **患者獲得** | CTが必要な患者（高齢者・慢性疾患）の紹介を開業直後から受けられる。近隣の高齢院長からの患者引き継ぎに有利 | CTなしでもかかりつけ医・内視鏡・外科処置で一定の患者確保は可能。70人/日到達後にCT追加で収益を段階的に積み上げ |
| **融資審査** | 2.44億円。前回面談で2億越えに難色あり。医療開業チームとの交渉が鍵 | 2.14億円に圧縮。担保（土地・自宅・個人資産8,000万）で余力十分。審査通過可能性が高い |
| **リスク** | 融資不成立リスク・開業初期の高固定費負担。CT稼働率が低い場合の機器費回収が長期化 | M18まで「CT紹介できない」ことによる患者機会損失。CT導入時の追加融資交渉が必要 |
| **船井総研推奨** | — | ✅ 「BEP 60〜70人到達後にCT導入」を推奨 |

## ⑤　院長への検討ポイント

| 論点 | 考え方 |
|---|---|
| CTなしで70人/日に到達できるか | 診療圏調査51名ベース＋6科標榜・内視鏡・外科処置で70人到達は現実的。ただしCTを期待して来院する患者層（救急・高齢者）は大病院へ流れる。 |
| CT導入を後回しにした場合のブランド毀損リスク | 「後からCTを入れたクリニック」という印象にはならない。むしろ成長に合わせた経営判断として評価できる。ただし開業時の広告・HPでCT訴求はできない。 |
| 宮銀の審査通過優先か医療機能優先か | Scenario Bは審査通過の確実性が高い。Scenario Aは医療機能面で有利だが融資交渉のリスクを伴う。公庫（最大7,200万）との協調融資でScenario Aの融資額を分散する選択肢もある。 |
| 建物設計への影響 | どちらのシナリオでも**CT室スケルトン対応は設計に組み込む**ことが必須。Bを選択した場合でもCT室の空間・電源・換気を確保しておけば将来の追加工事費を最小化できる。AAO建築アトリエへ確認要。 |

※ いずれのシナリオでも内視鏡（経鼻内視鏡・上部消化管）は開業時から導入（船井総研 関根様も同意見）